

**Diretoria de Assistência à Saúde
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial
Gerência de Serviços Especiais
Coordenação de Saúde Mental**

Nota Orientativa nº 01/2025 – SES.DAS

Assunto: Estabelece e orienta estratégias no manejo do usuário em crise psiquiátrica aguda nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Município de Joinville.

Considerando a [Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990](#), que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a [Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011](#), que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde;

Considerando a [Lei nº 10.216, de 06 de abril 2001](#), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental;

Considerando o artigo 1º da [Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002](#), que “Estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional”.

Considerando a necessidade de alinhamento e orientação, aos profissionais que atuam no Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), quanto às estratégias no manejo do usuário em crise psiquiátrica aguda;

A Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, a Gerência de Serviços Especiais e Coordenação de Saúde Mental publicam a **Nota Orientativa nº 01/2025 – SES.DAS**, que estabelece e orienta estratégias no manejo do usuário em crise psiquiátrica aguda nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Município de Joinville.



DEFINIÇÃO

A crise em Saúde Mental é definida como qualquer situação em que o comportamento de uma pessoa o impeça de cuidar de si mesmo, coloque-o em risco de ferir a si próprio ou a outras pessoas e/ou reduza a sua capacidade doméstica e laborativa. A crise gera alterações do pensamento ou conduta que demandam atendimento rápido e assertivo por parte da equipe de assistência.

Um estado de crise pode ser desencadeado por diversos fatores que interferem na capacidade do usuário e pode apresentar como sintomas: alucinações visuais e auditivas, delírios, agitação psicomotora, episódios de auto e hetero-agressividade, dentre outros.

Os quadros mais comuns associados à crise e emergência psiquiátrica são: esquizofrenia, psicoses agudas, crises de ansiedade, estresse e pânico, eventos traumáticos, luto, intoxicação exógena, uso de substâncias psicoativas, abstinência, ideações suicidas, entre outras.

ETAPAS DO ATENDIMENTO EM UMA SITUAÇÃO DE CRISE

O atendimento em situações de crise deve ser realizado de forma rápida, focado na solução, proteção e recuperação do usuário. Para isso, é fundamental que a equipe esteja preparada para agir quando necessário.

As etapas de atendimento devem seguir os passos descritos abaixo, podendo avançar passos quando os anteriores não forem possíveis de serem aplicados:

1. Designar os profissionais para conduzir o atendimento da **escuta qualificada**;
2. Realizar o **manejo ambiental**, garantindo um local seguro para o atendimento.
3. Iniciar o **manejo verbal**, constatando-se que este foi insuficiente para solução da crise, deve-se acionar o médico da Unidade para iniciar o processo de **contenção química** (intervenção medicamentosa);
4. Havendo recusa do usuário para o uso de medicação ou sendo a contenção química insuficiente para solução da crise ou, uma vez constatado que as atitudes do usuário continuam colocando a si ou a terceiros em risco, deve-se solicitar nova avaliação médica ou com o enfermeiro para prescrição da **contenção física**. A contenção física pode ser aplicada seguida de nova tentativa de contenção química, mediante prescrição médica.

5. Constatando-se a ineficácia das contenções química e física, deve-se solicitar avaliação médica para **contenção mecânica**.
6. Não havendo melhora do quadro ou no caso da contenção mecânica mostrar-se insuficiente e sem possibilidade de manejo em serviço aberto (CAPS), deve-se acionar o SAMU para transferência e notificar a família/rede de apoio do usuário referente ao encaminhamento do usuário para serviço de urgência.

ESTRATÉGIAS PARA MANEJO E CONTENÇÃO DA CRISE

Escuta qualificada: É o momento do atendimento em que o técnico ouve atentamente a demanda trazida pelo usuário ou familiar, ajuda a pensar nas possibilidades de ação frente a demanda apresentada e define ações mais assertivas para escolha/definição do Plano de Atendimento Individual.

Manejo ambiental (ambiência): Configura-se como a organização do espaço físico, proporcionando um ambiente mais protegido, que minimize estímulos externos, visando aumentar a segurança do usuário, da equipe e de outras pessoas inseridas no local, buscando ajudar o usuário a controlar seu impulso agressivo. Faz parte do manejo ambiental:

- Afastar outros usuários do local;
- Informar a equipe assistencial para suporte;
- Retirar objetos ou aparelhos que possam ser quebrados, arremessados ou mesmo usados como artefatos para agressão;
- Facilitar o acesso à porta de saída tanto para a equipe como para o usuário¹
- O atendimento deve ser conduzido por mais de um profissional da equipe de saúde ou com a presença dos profissionais que fazem a segurança da Unidade pois sua presença ajuda a coibir comportamentos violentos de maneira significativa;
- Reduzir ao máximo a exposição e influência de estímulos ambientais;
- Evitar a participação de pessoas que possam desestabilizar o usuário (Ex: um familiar com quem o usuário tem uma relação conflituosa, ou um membro da equipe que o usuário envolveu em seus delírios);
- Evitar discussão do caso entre os profissionais na presença do usuário.

¹ Alguns usuários com padrão comportamental de características persecutórias podem se sentir acuados, o que aumentaria o risco de agressão física.

Manejo verbal: Tem o objetivo identificar o tipo de crise e sintomatologia presente. Ocorre nas ações de comunicação com o usuário em crise, busca estabelecer vínculo, confiança e respeito entre o técnico e o usuário a fim de que ele se sinta acolhido e consiga restabelecer o contato com a realidade, controle dos próprios impulsos e consiga aceitar a intervenção do profissional. Recomenda-se:

- Minimizar o tempo de espera do usuário para o atendimento;
- O profissional deve adotar uma atitude confiante, respeitosa e atenciosa e evitar infantilizar o usuário;
- Na condução do manejo pode-se trazer dados de realidade, perguntar sobre como o usuário está se sentindo; quais suas necessidades; estabelecer acordos e negociações;
- O profissional deve estabelecer uma comunicação objetiva e clara, com ritmo de fala pausado e articulado, evitando frases hostis ou demasiadamente autoritárias;
- O usuário deve ser estimulado a expressar seus sentimentos em palavras e a equipe deve reforçar a capacidade do usuário de autocontrole;
- Objetiva-se estabelecer um vínculo de confiança e respeito com o usuário de modo que ele se sinta acolhido e com seu sofrimento reconhecido;
- O profissional deve evitar movimentos bruscos e olhar diretamente para o usuário;
- Recomenda-se manter uma distância de segurança e não fazer anotações durante esse manejo;

Contenção Química: Caracterizada pela prescrição terapêutica psicoativa (medicamentos) utilizada para inibir um determinado comportamento ou movimento. Realiza-se somente nos casos de ineficácia do manejo verbal e somente com prescrição médica.

Na ausência do profissional médico na Unidade e, na ineficácia do manejo verbal, a equipe tem a possibilidade de consultar a existência de prescrição médica válida para contenção química e a disponibilidade de medicação para o procedimento.

Caso não haja prescrição e o usuário esteja colocando a si ou terceiros em risco, deve-se acionar o SAMU para transferência e notificar a família/rede de apoio do usuário referente ao encaminhamento do usuário para serviço de urgência.

Contenção Física: Procedimento de imobilização do usuário caracterizado pelo uso de técnicas manuais, adotadas por várias pessoas da equipe, que o seguram firmemente no

solo. O intuito da contenção física é limitar as ações do usuário nos momentos em que ele oferece perigo para si e para terceiros, caracterizando como intervenção de segurança e não como recurso terapêutico.

Deve ser adotada como estratégia nos casos de recusa do usuário para o uso de medicação ou quando a contenção química é insuficiente para solução da crise, ou ainda quando as atitudes do usuário continuam colocando a si ou a terceiros em risco. Essa estratégia deve ser prescrita após nova avaliação médica ou com o enfermeiro para que seja adotada pela equipe.

Essa estratégia de contenção necessita de, no mínimo, 5 pessoas para aplicação da técnica do “grupo de 5”. Como proceder:

Preparação:

- O grupo que fará a contenção deve eleger um coordenador, que terá a responsabilidade de orientar os demais integrantes da equipe sobre as etapas das abordagens com o usuário. É importante considerar que todos os participantes devem estar preparados para assumir esse papel a qualquer momento.
- O Grupo deve, previamente, combinar uma frase ou uma palavra que será a “senha” proferida pelo coordenador para que, ao final da verbalização, os membros do grupo iniciem a contenção de forma sincronizada;
- Outra estratégia é a escolha de frases que alertem os membros do grupo para se posicionar para a ação. Como exemplo:: “Precisamos conversar sobre seu tratamento”, “O senhor está um pouco alterado, vamos conversar em outro lugar?”;
- No início da abordagem, desaconselha-se que os membros do grupo se posicionem atrás do usuário, por risco de agravamento do quadro agressivo e, conseqüentemente, aumento da dificuldade no procedimento.

Abordagem e contenção:

- Ao abordar o usuário, a equipe deve ficar posicionada em semicírculo, reduzindo a área em torno dele, a fim de limitar a sua movimentação. Cada profissional deve se posicionar da seguinte forma:
 - a. um profissional para cada membro superior;
 - b. um profissional para cada membro inferior;
 - c. o coordenador no tórax e para a cabeça.



- Com esse posicionamento é possível, na maioria das vezes, realizar a contenção de forma adequada e segura, evitando riscos de grandes lesões tanto para o usuário quanto para os profissionais.
- Assim que a palavra ou a frase escolhida como “senha” for proferida os membros do grupo segurarão as partes designadas conforme seu posicionamento;
- O coordenador posicionar-se-á atrás do usuário e segurará a cabeça e o tórax de forma concomitante. Uma mão apoiará o tórax do usuário, passando o braço por baixo da axila e a outra mão se posicionará na região frontal do crânio, para que se tenha o controle dos movimentos da cabeça e evite possíveis lesões por mordedura.

Não são medidas terapêuticas aplicáveis para contenção:

- “Chave de braço”;
- Torção de punho;
- Pisar no pé;
- Enforcamento;
- Segurar o usuário passando os membros superiores do profissional por baixo das axilas cruzando as mãos e prendendo a região occipital da cabeça.

Contenção Mecânica: Procedimento de imobilização do usuário, realizado apenas com prescrição médica e monitoramento constante, onde se utilizam dispositivos mecânicos como: faixas, ataduras, gazes, lençóis, envoltas nos pulsos e tornozelos para fixar o usuário ao leito.

Esse procedimento ocorre após a contenção física, quando há necessidade de transferir o usuário para uma maca ou leito, onde este será contido por faixas (para tanto estas devem estar de fácil acesso).

- Os profissionais devem se posicionar em frente à maca ou leito, mantendo o usuário elevado para ser posicionado acima do leito e, na sequência, movido em direção à cabeceira.
- O usuário deve ser mantido em posição anatômica e cada profissional deverá se manter segurando a parte do corpo específica do usuário fixada ao leito.
- O profissional que está contendo o membro inferior necessita imobilizar as principais articulações da perna (joelho e tornozelo), usando cada uma de suas



- mãos para essas áreas, colocando todo o peso da parte superior do seu corpo contra a área contida, firmando-a contra a maca ou leito;
- O profissional que está posicionado no membro superior necessita imobilizar as principais articulações do braço (pulso e fossa antecubital), usando cada uma de suas mãos para essas áreas, colocando todo o peso da parte superior do seu corpo contra a área contida, firmando-a contra a maca ou leito;
 - As faixas devem estar de fácil acesso no ambiente em que o usuário está sendo contido, ou levadas pela equipe durante a abordagem. Deve-se sempre iniciar a imobilização pelo membro contido que apresenta o maior risco de ser solto pelo usuário.
 - O profissional que ocupa a posição de “coordenador” deve estar livre para aplicar as faixas e decidir por onde iniciará a imobilização do usuário.
 - O tórax deve ser a última área contida por faixa e deve ocorrer após todos os membros já estarem contidos. Tal recomendação se dá devido à possibilidade de adequação no posicionamento dos membros superiores.

Cuidados com o usuário após a contenção mecânica:

- Manter a elevação da cabeça do usuário;
- Observar perfusão sanguínea arterial e pulsos periféricos;
- Nos casos envolvendo Contenção Química seguida da Contenção Mecânica, deve-se observar os efeitos colaterais e a ação específica dos fármacos;
- Cuidados gerais como hidratação, alimentação, higiene corporal, eliminações e mudança de decúbito;
- Nos casos em que a contenção mecânica precise permanecer por mais de duas horas o usuário deverá ser reavaliado pelo médico;
- O enfermeiro deverá avaliar o usuário a cada 30 minutos;
- O tempo de duração da contenção deve ser discutido pela equipe, respeitando a individualidade de cada caso;
- Antes de proceder com a liberação do usuário da contenção mecânica, deve-se efetuar um “contrato verbal” com ele, deixando claros os motivos da sua contenção;
- É preciso orientá-lo para que, ao final da retirada das faixas, não se levante de forma brusca e/ou rápida, sob o risco de ocorrer hipotensão ortostática.
- Orienta-se a movimentar cada membro liberado, de forma regular, flexionando-o por alguns breves instantes.



REFERÊNCIAS

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasil, Brasília – DF: 1990.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 10216, de 06 de abril de 2001**. Dispõe Sobre A Proteção e Os Direitos das Pessoas Portadoras de Transtornos Mentais e Redireciona O Modelo Assistencial em Saúde Mental. Brasília – DF: 2001.

BRASIL.Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002**. Estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional. Brasil, Brasília – DF: 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011**. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasil, Brasília – DF: 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência**. Brasília – DF: 2016.

BRASIL. Secretaria da Saúde do Estado do Maranhão. Departamento de Atenção à Saúde Mental. **Protocolo Clínico de Urgência e Emergência em Saúde Mental**. São Luís – MA: 2017.

